認定調査票(概況調査)

テスト用架空事例

Ⅰ 調査実施者(記入者)

実施日時	令和8年10月　日　(テスト用)
実施場所	自宅
記入者氏名・所属	＊＊＊＊(テスト用)

Ⅱ 調査対象者

過去の認定	更新申請(前回:要介護5)		
対象者氏名	林 トミ (はやし とみ)	性別	女
生年月日	昭和13年(1938年)3月25日	年齢	88歳
現住所	○○県○○市＊＊＊＊(テスト用)		
家族等連絡先	＊＊＊＊(テスト用)		

Ⅲ 現在受けているサービスの状況

訪問介護(身体介護) 毎日1回(朝のおむつ交換・体位変換)/訪問看護 週2回/訪問入浴介護 週1回/福祉用具貸与:特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、車いす(リクライニング型)、車いす付属品/居宅療養管理指導(訪問診療の主治医)月2回。

Ⅳ 置かれている環境等(調査対象者の家族状況、調査対象者の居住環境、日常的に使用する機器・器械の有無等)

家族状況	夫は10年前に他界。長男(62歳・退職済み)と長男の妻(60歳・主介護者)と同居。長男の妻は腰痛があり、夜間の体位変換と痰の吸引で睡眠が細切れになっている。長女(58歳)は市外在住で月1回来て、長男の妻を手伝う。
居住環境	持ち家の木造平屋。本人は居間の隣の洋室で特殊寝台を使用。室内の段差は住宅改修で解消済み(前回の認定期間中に実施)。
使用している機器等	特殊寝台、エアマットレス、リクライニング型車いす、吸引器(自費購入)。
生活歴	農家の長女として生まれ、結婚後も夫と米づくりを続けた。歌が好きで、元気な頃は地区の民謡の会に入っていた。「最期は家で迎えたい」と、倒れる前から家族に話していた。
本人・家族の主訴	本人:発語はほとんどないが、なじみの民謡を流すと穏やかな表情になる。 長男の妻:「できるだけ家で看てあげたい。ただ、夜の吸引と体位変換で眠れない日が続いていて、自分の腰も心配。」 長男:「母の希望だったので、家で最期まで看てやりたい。」

認定調査票(基本調査)

テスト用架空事例

該当する選択肢を〇で囲んでいます。

第1群 身体機能・起居動作	
1-1 麻痺等の有無 (複数選択可)	ない　(左上肢)　右上肢　(左下肢)　右下肢　その他(四肢の欠損)
1-2 拘縮の有無 (複数選択可)	ない　(肩関節)　(股関節)　(膝関節)　その他(四肢の欠損)
1-3 寝返り	つかまらないでできる　何かにつかまればできる　(できない)
1-4 起き上がり	つかまらないでできる　何かにつかまればできる　(できない)
1-5 座位保持	できる　自分の手で支えればできる　(支えてもらえればできる)　できない
1-6 両足での立位保持	支えなしでできる　何か支えがあればできる　(できない)
1-7 歩行	つかまらないでできる　何かにつかまればできる　(できない)
1-8 立ち上がり	つかまらないでできる　何かにつかまればできる　(できない)
1-9 片足での立位	支えなしでできる　何か支えがあればできる　(できない)
1-10 洗身	介助されていない　一部介助　(全介助)　行っていない
1-11 つめ切り	介助されていない　一部介助　(全介助)
1-12 視力	普通(日常生活に支障がない)　約1m離れた視力確認表の図が見える　目の前に置いた視力確認表の図が見える　ほとんど見えない　(見えているのか判断不能)
1-13 聴力	普通　普通の声がやっと聞き取れる　(かなり大きな声なら何とか聞き取れる)　ほとんど聞えない　聞えているのか判断不能
第2群 生活機能	
2-1 移乗	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)
2-2 移動	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)
2-3 えん下	できる　見守り等　(できない)
2-4 食事摂取	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)
2-5 排尿	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)
2-6 排便	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)
2-7 口腔清潔	介助されていない　一部介助　(全介助)
2-8 洗顔	介助されていない　一部介助　(全介助)
2-9 整髪	介助されていない　一部介助　(全介助)
2-10 上衣の着脱	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)
2-11 ズボン等の着脱	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)
2-12 外出頻度	週1回以上　月1回以上　(月1回未満)
第3群 認知機能	
3-1 意思の伝達	調査対象者が意思を他者に伝達できる　ときどき伝達できる　(ほとんど伝達できない)　できない
3-2 毎日の日課を理解	できる　(できない)
3-3 生年月日や年齢を言う	できる　(できない)
3-4 短期記憶	できる　(できない)
3-5 自分の名前を言う	できる　(できない)
3-6 今の季節を理解する	できる　(できない)
3-7 場所の理解	できる　(できない)

3-8 徘徊	(ない)　ときどきある　ある
3-9 外出すると戻れない	(ない)　ときどきある　ある
第4群 精神・行動障害	
4-1 物を盗られたなどと被害的になる	(ない)　ときどきある　ある
4-2 作話	(ない)　ときどきある　ある
4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる	(ない)　ときどきある　ある
4-4 昼夜の逆転がある	(ない)　ときどきある　ある
4-5 しつこく同じ話をする	(ない)　ときどきある　ある
4-6 大声をだす	(ない)　ときどきある　ある
4-7 介護に抵抗する	ない　(ときどきある)　ある
4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがない	(ない)　ときどきある　ある
4-9 一人で外に出たがり目が離せない	(ない)　ときどきある　ある
4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくる	(ない)　ときどきある　ある
4-11 物を壊したり、衣類を破いたりする	(ない)　ときどきある　ある
4-12 ひどい物忘れ	(ない)　ときどきある　ある
4-13 意味もなく独り言や独り笑いをする	(ない)　ときどきある　ある
4-14 自分勝手に行動する	(ない)　ときどきある　ある
4-15 話がまとまらず、会話にならない	(ない)　ときどきある　ある
第5群 社会生活への適応	
5-1 薬の内服	介助されていない　一部介助　(全介助)
5-2 金銭の管理	介助されていない　一部介助　(全介助)
5-3 日常の意思決定	できる(特別な場合でもできる)　特別な場合を除いてできる　日常的に困難　(できない)
5-4 集団への不適応	(ない)　ときどきある　ある
5-5 買い物	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)
5-6 簡単な調理	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)

その他 過去14日間に受けた特別な医療

□点滴の管理　□中心静脈栄養　□透析　□ストーマ(人工肛門)の処置　□酸素療法　□レスピレーター(人工呼吸器)　□気管切開の処置　□疼痛の看護　■経管栄養　□モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)　■じょくそうの処置　□カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

日常生活自立度

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)	自立　J1　J2　A1　A2　B1　B2　C1　(C2)
認知症高齢者の日常生活自立度	自立　Ⅰ　Ⅱa　Ⅱb　Ⅲa　Ⅲb　(Ⅳ)　M

認定調査票(特記事項)

テスト用架空事例

第1群 身体機能・起居動作	1-1 左上下肢は完全麻痺。右上下肢も筋力低下が強く、自分で動かすことはほとんどない。 1-2 左肩・両股関節・両膝関節に拘縮あり。おむつ交換の時に股を開くのが難しい。 1-3・1-4 自分では寝返り・起き上がりができず、2〜3時間ごとに家族・訪問介護員・訪問看護師が体位変換をしている。 1-5 リクライニング型車いすで、背もたれとクッションで支えて30分程度座っていられる。 1-10 週1回の訪問入浴介護で全身を洗っている。それ以外の日は長男の妻が清拭をしている。 1-12・1-13 視力確認表の図を示したが反応がなく、判断できなかった。耳元で大きな声で呼びかけると、目を開けて声の方を見る。
第2群 生活機能	2-1・2-2 ベッドから車いすへは、長男と長男の妻の2人がかりで抱えて移乗している。移動はすべて車いすを押してもらう。 2-3・2-4 誤嚥性肺炎を繰り返し、半年前に胃ろうを造設。口からは何も食べていない。栄養剤の注入(1日3回)は長男の妻と訪問看護師が行っている。 2-5・2-6 おむつを使用。1日5〜6回の交換を長男の妻と訪問介護員が行っている。排便は訪問看護師が週2回、摘便と浣腸で調整している。 2-7 口腔ケアはスポンジブラシで長男の妻が1日3回行っている。痰がからみやすく、吸引器で吸引をしている(夜間も2〜3回)。 2-12 月1回、天気のよい日に車いすで庭に出る程度。
第3群 認知機能	3-1 発語はほとんどない。名前を呼ぶと目を開けることがあるが、うなずきなどの意思表示ははっきりしない。 3-2〜3-7 質問に対する反応がなく、すべて「できない」とした。
第4群 精神・行動障害	4-7 おむつ交換の時に、右手で介護者の手を払いのけることが週に数回ある。
第5群 社会生活への適応	5-1 薬はすべて胃ろうから、長男の妻・訪問看護師が注入している。 5-2・5-5・5-6 金銭の管理・買物・調理はすべて長男夫婦が行っている。 5-3 日常の意思決定はできない。
特別な医療	経管栄養:胃ろう(1日3回の栄養剤注入)。 じょくそうの処置:仙骨部に褥瘡(約2cm×3cm、真皮までの深さ)あり。訪問看護師が週2回処置し、毎日の軟膏塗布と保護は長男の妻が行っている。

主治医意見書

テスト用架空事例

申請者	林 トミ　(女・88歳)　医療機関名・医師氏名:＊＊＊＊(テスト用)

1. 傷病に関する意見

(1)診断名	発症年月日
1. 脳出血(右被殻)後遺症:左片麻痺、血管性認知症	約2年前
2. 誤嚥性肺炎(反復)、胃ろう造設後	半年前
3. 仙骨部褥瘡	約2か月前

(2)症状としての安定性	不安定
(3)経過及び治療内容	2年前に脳出血を発症し、左片麻痺と重度の認知機能障害が残った。誤嚥性肺炎を3回繰り返したため、半年前に胃ろうを造設。2か月前から仙骨部に褥瘡が生じ、訪問看護で処置中。痰が多く、吸引が必要。訪問診療(月2回)で全身状態を管理している。 投薬(胃ろうより):降圧薬、去痰薬、整腸剤、下剤、褥瘡治療用外用薬。

2. 特別な医療(過去14日間以内に受けた医療)

経管栄養、じょくそうの処置

3. 心身の状態に関する意見

(1)日常生活の自立度等	障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度):C2　認知症高齢者の日常生活自立度:Ⅳ
(2)認知症の中核症状	短期記憶:問題あり/日常の意思決定:判断できない/意思の伝達:伝えられない
(3)認知症の行動・心理症状	介護への抵抗(軽度)
(4)その他の精神・神経症状	なし
(5)身体の状態	利き腕:右/身長145cm・体重35kg/左上下肢の麻痺(重)/右上下肢の筋力低下(重)/関節の拘縮(左肩・両股・両膝)/褥瘡:仙骨部(重)

4. 生活機能とサービスに関する意見

(1)移動	屋外歩行:していない/車いす:主に他人が操作(リクライニング型)/歩行補助具:なし
(2)栄養・食生活	食事行為:全面介助(経管栄養)/栄養状態:不良/留意点:栄養剤の注入時は上体を30度以上起こす
(3)現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針	褥瘡の悪化、誤嚥性肺炎、低栄養、脱水、易感染性 → 体位変換と除圧、口腔ケアと吸引、栄養・水分の管理、感染予防
(4)サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し	期待できない
(5)医学的管理の必要性	訪問診療、訪問看護、訪問歯科衛生指導、訪問栄養食事指導、短期入所療養介護
(6)サービス提供時における医学的観点からの留意事項	嚥下:経口摂取は不可。その他:注入後30分は上体を起こしておく。発熱・痰の増加・褥瘡の悪化は早めに連絡。
(7)感染症の有無	なし

5. 特記すべき事項

家族は自宅での看取りを希望している。主介護者(長男の妻)の疲労が強く、介護負担の軽減策が必要。急変時の対応方法を家族と共有しておくこと。